

TOXOPLASMOSE ET GROSSESSE

I. Introduction - définition

- Toxoplasmose :
 - «toxoplasma gondii » : protozoaire de classe des coccidies
 - L'infection maternelle est bénigne
 - Discrète ou inaperçue (80%)
 - Syndrome grippal, adénopathies cervicales
- Si atteinte fœtale: Risque d'atteinte neurologique et oculaire

II. Epidémiologie

- Environ 50 % des femmes enceintes ne sont pas immunisées lors de leurs grossesses
- 1 à 2 % des femmes enceintes présenteront une séroconversion au cours de leurs grossesses
 - 15% des enfants contaminés in-utero présenteront une pathologie sévère à la naissance
 - 85% de ces enfants seront asymptomatiques à la naissance mais peuvent développer des séquelles ultérieurement en l'absence de traitement

TOXOPLASMOSIS

CAUSE

* PROTOZOAN PARASITE
TOXOPLASMA GONDII

* PREGNANT INDIVIDUALS

~ CONTACT w/ CAT FECES

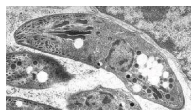
~ CONSUMPTION of UNDERCOOKED MEAT



III. Pouvoir pathogène et transmission materno-fœtale

Les tachyzoïtes

- Intracellulaires (macrophages, cellules gliales, muscles)
- Forme arquée
- Endodyogénie asexuée rapide
- Infestant mais détruits par l'acidité gastr



Les bradyzoïtes

- Intratissulaires : kystes (système nerveux, rétine, muscles)
- Endodyogénie asexuée lente
- Persistent toute la vie de l'hôte
- Infestants +++
 - Résistent à l'acidité gastrique
 - Détruits par cuisson et congélation

TG se présente sous 3 formes:

- **Forme végétative** : tachyzoite

o C'est la forme responsable des lésions tissulaires et de l'inflammation

o Forme très fragile, endo-cellulaire, son ingestion n'entraîne pas de contamination

- **Forme kystique** : kystes contiennent des bradyzoïtes

- Forme persistante chez l'hôte intermédiaire, la multiplication très lente se fait dans les cellules nerveuses et musculaires, forme immunogène résistante à l'acide chlorhydrique et aux températures n'excédant pas 45°

- **L'oocyste**: Sporozoite, forme de survie, forme très résistante puisqu'elle est retrouvée partout où il y a des déjections d'animaux infectés. Elle est responsable de la contamination des hommes par ingestion d'aliments souillés

Cycle parasitaire:

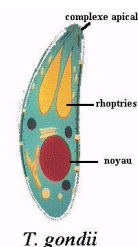
- Son cycle avec le chat comme hôte définitif
- L'homme s'infecte le plus souvent par ingestion de viande ou d'aliments contaminée par la forme kystique du parasite t. Gondii

Multiplication sexuée

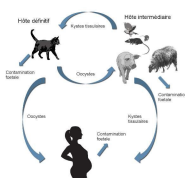
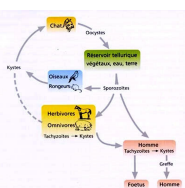
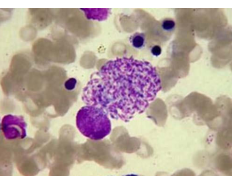
- Hôte définitif (chat et autres félinés)
- Ingestion de kystes
- Epithélium digestif
- Milieu extérieur

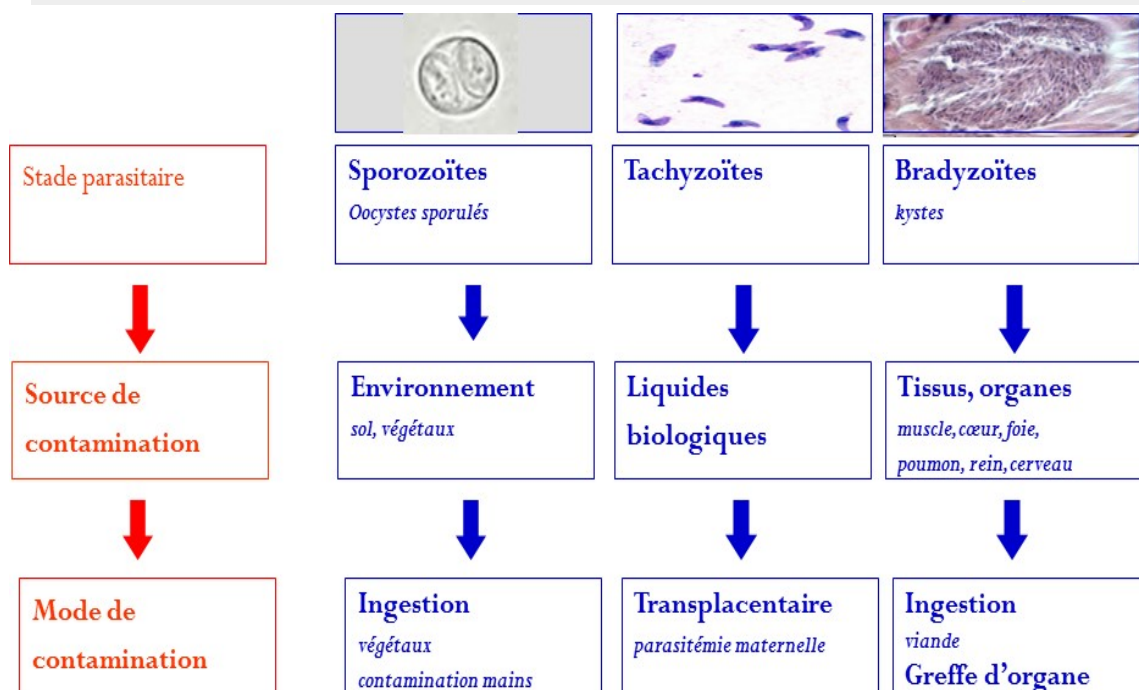
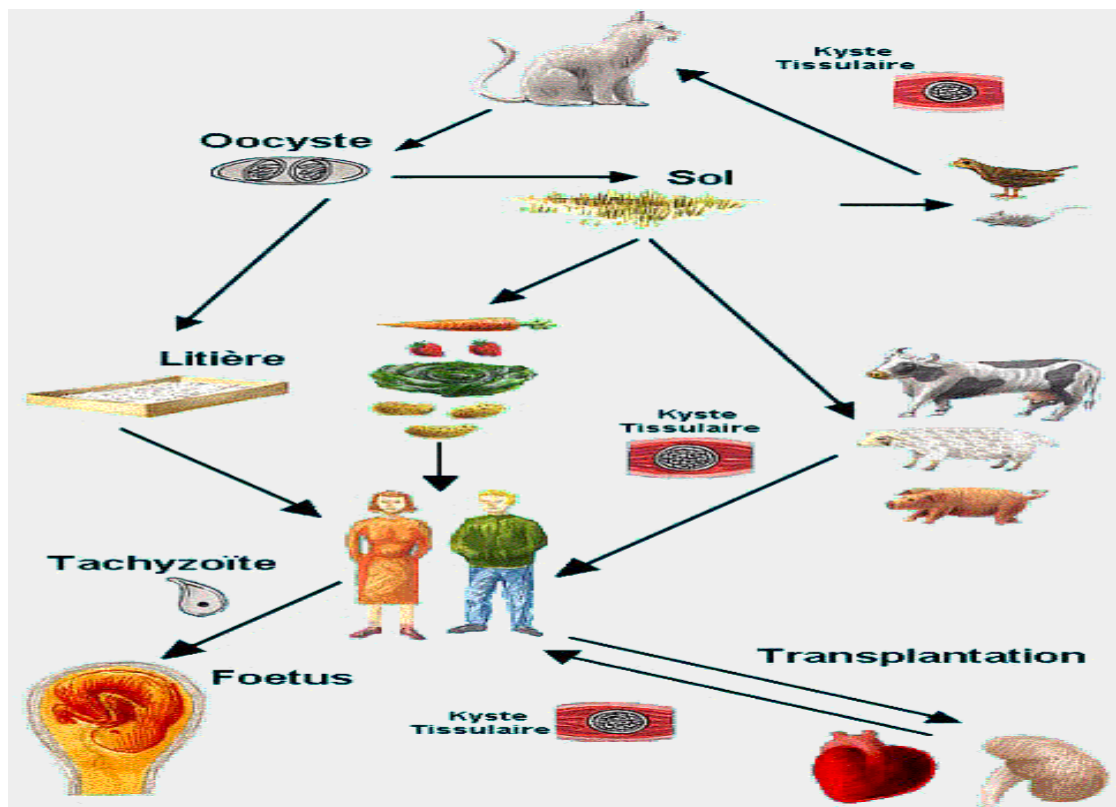
Multiplication asexuée

- Hôte intermédiaire
- Ingestion d'oocystes
- Différents types cellulaires
- Kystes tissulaires (muscles, cerveau)



T. gondii



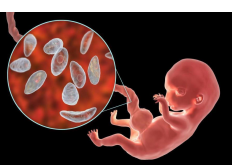


• Transmission à l'homme:

- Une fois dans le tube digestif de l'homme, le toxoplasme va passer la barrière intestinale, infecter les macrophages, puis disséminer avec une parasitémie pour enfin former des kystes dans les tissus cibles (muscles et système nerveux)
- Chez la femme enceinte, le toxoplasme va également atteindre le placenta et les tissus fœtaux

• Transmission materno-fœtale:

- En début de grossesse, la barrière placentaire très efficace → le risque de transmission est minime mais augmente avec l'âge gestationnel
- Par contre si infection en début de grossesse les lésions retrouvées sont graves
- La transmission de la mère au placenta se fait au moment de la parasitémie soit en tout début d'infection alors que la mère est asymptomatique
- Le risque de transmission verticale augmente avec l'âge gestationnel allant de 6% à 13 SA à 72% à 36 SA



- Révélation peut être tardive +++

VI. Prise en charge thérapeutique

- Le traitement prénatal ne permet pas d'abaisser le risque de transmission, mais qu'il pourrait toutefois atténuer la gravité de la toxoplasmose congénitale
- À l'heure actuelle, nous ne disposons pas de données suffisantes pour confirmer que le traitement des mères qui connaissent une séroconversion pendant la grossesse permet de prévenir l'infection fœtale

1. Traitement préventif: parasitostatique

- Spiramycine: 3 millions d'ui x3/j poursuivi jusqu'à l'accouchement

2. Traitement curatif: parasiticide (PCR positif)

- Pyriméthamine: 50mg/j
- Sulfadiazine: 3g/j
- Acide folinique: 50mg deux fois par semaine

- ⇒ Lorsqu'une infection est présente chez la mère mais non chez le fœtus, la spiramycine est utilisée à des fins de prophylaxie fœtale (en vue de prévenir la propagation d'organismes de la mère au fœtus par l'intermédiaire du placenta)
- ⇒ La spiramycine est un antibiotique macrolide
- ⇒ Qui se concentre dans le placenta, mais qui ne le traverse pas facilement, ainsi, cet agent n'est pas fiable pour la prise en charge de l'infection fœtale
- ⇒ Son utilisation vise à prévenir la transmission verticale du parasite au fœtus et n'est donc indiquée qu'avant l'apparition d'une infection fœtale

3. Surveillance échographique:

- Echographie mensuelle jusqu'à l'accouchement
- Interruption médicale de grossesse: Infection avérée, PCR positive, signes échographiques évocateurs

4. Indications : QE +++

- Si IgG - :
 - ⇒ Femme enceinte séronégative
 - ⇒ Contrôle mensuel de la sérologie
- Si IgG + et IgM - :
 - ⇒ Infection ancienne
 - ⇒ 2ème prélèvement après 3 semaines
- Si IgG - et IgM + :
 - ⇒ Il peut s'agir d'une:
 - ⇒ Séroconversion au tout début
 - ⇒ Stimulation immunitaire polyclonale (virose ..)
 - ⇒ Refaire un prélèvement 3 semaines plus tard

- Si IgG + et IgM + :

- ⇒ Test précédent négatif: Séroconversion
- ⇒ Pas de statut connu: Refaire un prélèvement 3 semaines après:
 - ↳ Taux d'IgG stables : séroconversion ancienne
 - ↳ Taux ascendants : séroconversion récente

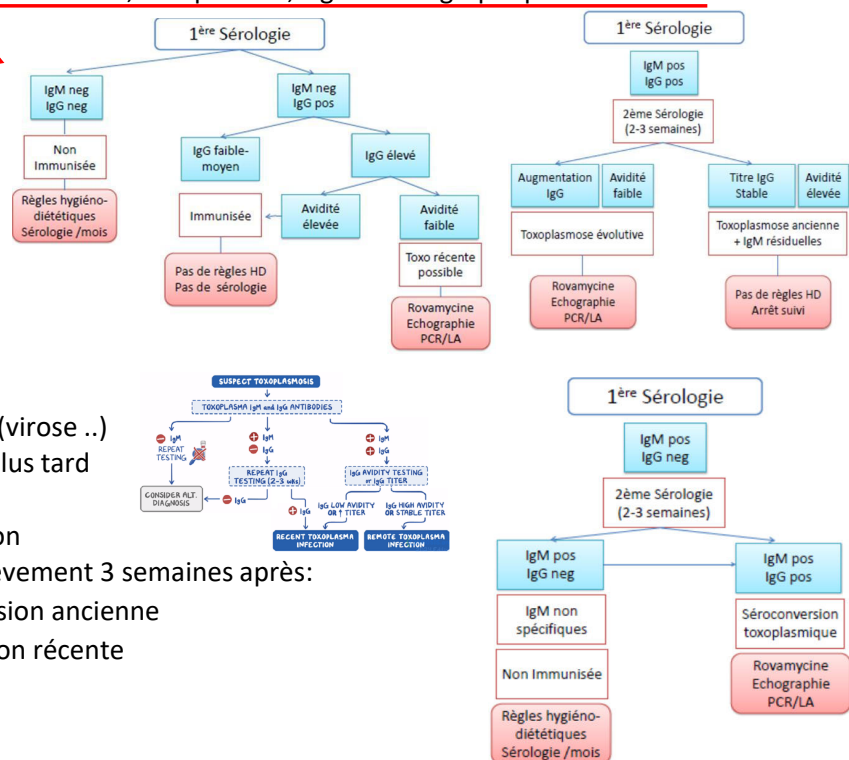
- Pratiquement...

• Sérologie négative pour la toxoplasmose:

- Sérologie mensuelle
- Règles hygiéno-diététiques:

➔ Eviter la contamination = précautions hygiéno-diététiques

QE!!



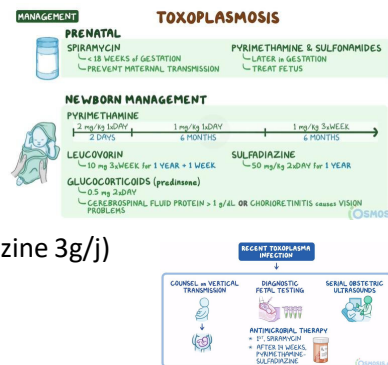
- Lavage des mains
- Cuisson suffisante des viandes (>65°C, congélation)
- Nettoyage des ustensiles
- Port de gants pour nettoyage des litières, jardinage

- Toxoplasmose aiguë chez la mère:

- Séroconversion: Spiramycine : 3 fois 3 mu/jour jusqu'à la fin de la grossesse
- Passage trans-placentaire, pcr liquide amniotique : (infection récente)
 - o Pyriméthamine (malocide 50mg/kg/j) et sulfadiazine (aldiazine 3g/j)
 - o Ou pyriméthamine et sulfadoxine (fansidar®) 2cp/sem
 - o Ac folinique (2 x 50mg / sem)
- Si anomalies échographiques avec atteinte sévère (lésions cérébrales) :
Discuter l'interruption thérapeutique de grossesse en RCP (réunion de concertation multidisciplinaire)

- Après la naissance:

- Diagnostic confirmé:
 - o Traitement pyriméthamine et sulfadoxine en cures pendant 1-2 ans
 - o Surveillance ophtalmologique jusqu'à l'adolescence
 - Diagnostic non confirmé: Surveillance sérologique jusqu'à 1 an
- ## - Examen du nouveau-né:
- Clinique:
 - o Examen neurologique complet
 - o Fond d'œil et radio du crâne face et profil
 - Sérologie: Rechercher les anticorps (IgG, IgM, IgA) du nouveau-né
 - Le suivi clinique et biologique de l'enfant est indispensable
 - En l'absence d'infection congénitale, les IgG transmises par la mère disparaîtront avant 1 an



VII. Prévention : QE ++

- Mesure de prévention primaire:
 - ✓ Bien faire cuire la viande à au moins 65°
 - ✓ Laver soigneusement légumes et plantes aromatiques surtout s'il ont touché à la terre
 - ✓ Eviter de consommer les crudités et préférer les légumes cuits, la viande doit être consommée bien cuite
 - ✓ Eviter le contact avec les objets qui pourraient être contaminés par les excréments de chat
 - ✓ Eviter le contact direct avec la terre et porter des gants pour le jardinage

VIII. Conclusion

- Grand risque d'infection congénitale
- Séroconversion toxoplasmose pendant la grossesse peut être grave engendrant le pronostic fœtal
- Traitement préventif doit être instauré précocement

